

14 주차

2) 질 감염 - 개설

	내용	진단 / 치료
★★★ 세균성 질증	- 비특이성 질염 / Gardnerella vaginitis 로 알려져있음. (가장 흔한 질염) - 의미: 정상 질 세균군의 변형으로 과산화수소를 생성하는 유산균이 감소되고 비호기성균이 과증식하는 것 (비호기성 세균 농도 100 배~1000 배 이상 증가) - 특이사항: 백혈구 증가 소견이 없음 (백혈구 증가소견이 있으면 세균성 질염) - 부작용: 골반염, 유산 후 골반염, 자궁절제술 후 질원개봉와직염, 자궁경부 세포의 이상빈도 증가 - 임신부: 조기파수, 융모양막염, 제왕절개술 후 자궁내막염 위험 증가 → 세균성 질증이 위 질환들을 유발한다기보다는 면역 약화로 기회감염의 확률이 높아지는 것	[★중요] 세균성 질증과 칸디다 질염의 진단 비교 강조 - 질 분비물 : 생선비린내(성교 후 심해짐), 회색, 산도 pH 4.5 이상 분비물의 양이 엄청 많진 않은 편(많은건 트리코모나스) - 현미경 검사 : clue cell 증가, 백혈구 수 현저히 감소 - 질염이라고 하지 않고 질증이라고 하는 이유: 백혈구 증가 소견이 보이지 않기 때문 - Whiff test (+) : 질분비물에 10% KOH 첨가 시 아민 같은 생선 냄새 ※세균성 질증은 병원 내원 비율이 적은 반면(증상이 심한 불편감을 주지는 않기 때문) 칸디다질염은 내원하는 환자 비율이 높은 편(가장 많음)
★★★ 칸디다 질염 (질 칸디다증)	- 유병률: 여성의 75%가 일생의 한 번쯤, 45% 여성이 1년에 2 회 이상 경험 (재발되는 경우 꽤 있음, 오치로 인해 악화되는 경우 多) - 원인: <u>Candida Albicans</u> 가 주요 원인 (85-90%) ↳ 질에만 있는 것이 아니라 구강, 위장 등 다른 부위에도 존재 기회성 면역체(기본적으로 상주해있다가 면역력이 약해질 때 발현됨.) ※칸디다는 형태적으로 분아포자, 균사체의 두 형태로 존재 분아포자: 전염을 일으킴, 전염과 무증상 colony 를 일으킴 균사체: 염증반응을 일으킴, 분아포자로부터 발생하여 조직 침투를 쉽게 함 - 특징: 상피세포 침습이 미미하더라도 세균의 독/효소에 의해 소양감, 염증이 광범위한 영역에서 발현됨 - 위험인자: 장기간 항생제(정상균까지 죽어서 곰팡이가 과성장), 임신/당뇨(세포면역 저하로 진균증 발생)	- 증상: 코티즈 치즈 덩어리(흰 두부를 으깬 모양) 같은 질 분비물(백색), 심한 소양증, 외음부 작열감(따가움), 성교통, 질 동통, 배뇨 시 통증, 외음순 및 외음부 피부의 부종과 홍반 등 - 질의 산도는 정상 (pH 4.5 이하) ↳ 정상일 수도 있고 비정상일 수도 있으나 세균성 질증처럼 유산균을 방해해하지 않으므로 산도는 정상인 경우가 많음. - 현미경 : 80%에서 진균 요소 (출아효모 형태/균사체) 확인 가능 (확진 by 진균 배양검사) - Whiff test (-) & Clue cell 없음. - 치료 by 항진균제 (무증약으로도 병용됨)

★편모충 질염 (트리코모나스 질염)	- 원인: 편모가 있는 기생충인 질편모충(<i>Trichomonas vaginalis</i>)에 의한 감염 - 특징: 명백한 성전파성 감염에 해당 - 증상: 질염 + 요도염 증상 (남성은 증상이 잘 나타나지 않음) - 전염성: 전염률 매우 높아 질병 가진 여성과 성교 후 남성 감염률 70% (남성에서 여성으로의 감염률은 더 높을 것으로 예상) - 동반 질환 : 세균성 질증 동반하는 경우 多 (60%)	- 증상: 상당히 많은 화농성(노란색) 냄새, 악취가 나는 분비물 + 외음&질의 상당한 가려움. - 특징: 균 농도 높을 경우 딸기모양 자궁목(반점형 질 홍반) 관찰, 미생물학적으로 질편모충을 관찰할 수 있으며, 백혈구가 증가되어 있음 ↳ 현미경 사진 다음시간에 보여줄 예정, 특징이 명확한 편 - 질 분비물 pH 5.0 이상 - Whiff test (+) & clue cell 관찰(세균질증과 동반되는 경우 많으므로)
염증성 질염	- 연쇄상구균에 감염되어 증상이 가장 맹렬함. - 특징: 광범위한 삼출성 질염, 상피세포 탈락, 화농성 질 분비물 교수님피셜: 최악의 질염이 염증성 질염(그다음이 트리코모나스, 칸디다 . . .)	
위축성 질염	- 폐경 여성(갱년기)에서 발생하는 염증성 질염 - E가 감소하여 질과 외음부 위축으로 상처받기 쉬운 상태 → 질염 발생 가능	- 증상: 질건조감, 화끈거림(작열감), 소양감, 성교통, 성교 후 질 출혈(마찰에 의한 출혈) 외에도 소증으로 갱년기 증상 - 질점막의 육안 소견 : 얇고 반들거리며 주름 소실된 부드러운 표면을 가진 붉은 색의 질 상피 - 치료: 에스트로겐 질 크림 (오래 사용 시 피복 경화를 유발하고 정확한 부위에 바르기 어려워 문제가 있음. 한방 치료가 좋음)

※ 질 감염 - 진단요점

★ 세균성질증과 칸디다성 질염의 실험실적 진단상의 차이를 쓰시오. '19

★★★ 세균성 질증과 칸디다 질염의 진단상의 감별점을 쓰시오 '10,11,12,14,18

		세균성 질증	칸디다 질염	트리코모나스 질염
대표 원인		비호기성 세균 (Gardnerella vaginalis)	곰팡이 (Candida Albicans)	기생충 / 성전파감염 (Trichomonas vaginalis)
분비물 특징		생선 비린내, 얇은 회색 분비물	코티즈 치즈 같은 백색 (흰 두부찌꺼기)	양이 많고 악취가 나는 화농성 분비물
진단	분비물 pH	4.5 이상	4.5 이하(정상)	5.0 이상
	clue cell	있음	없음 (세균과 무관)	있음
	*Whiff test	양성	음성	양성
		백혈구가 현저히 적음	KOH 표본에서 진균 균사체 확인 진균 배양검사로 확진	현미경 검사로 편모성 원충 관찰하면 확진
증상	가려움/동통	없음	심함	가장 심함
	특징	항생제 먹으면 나아짐	외음부 작열감 성교통 질동통 배뇨통	딸기모양 자궁목 (반점형 질 홍반)
			항생제 먹으면 심해짐	60%에서 세균성 질증과 동반

- Whiff test: 질 분비물에 10% KOH 첨가했을 때 아민(암모니아와 유사)로 인해 역한 비린내가 올라오면 양성 → Whiff test로 세균성 질증과 칸디다 구분 가능!
- clue cell: 세균성 질염에서 특징적으로 나타나는 단서 세포(clue cell)가 현미경 상에서 관찰되는데, 이는 질 상피세포 표면에 많은 세균이 부착되어 있는 것

3. 자궁경부(자궁목)

- 자궁목은 편평상피와 선상피로 구성됨.
- 외자궁경관의 염증: 편모충, 칸디다, 단순 헤르페스 바이러스에 의해 발생
(질염을 일으킬 수 있는 균이나 곰팡이 등에 의해서 상피염증 유발)
- 내자궁경관의 염증: 임균, 클라미디아에 의해 화농성 염증을 유발함.
(내자궁경관을 이루는 선상피에서만 염증 일으킴, 황록색 mucopus가 나온다고 하지만 실제 임상에서는 드름)
※클라미디아는 증상이 거의 없어 감염되지 자각하기 어려우나, 면역력이 낮아지고 다른 감염에 취약해지기 때문에 문제가 됨.

4. 자궁체부(자궁몸통)

- 자궁내막염: 자궁내막은 해부학적 특성상 피를 담아두었다 쏟아내는 것을 반복하는 기관이기 때문에 염증 발현이 흔하지 않음.
(단, 클라미디아, 임균 등의 성전파성 균들에 의해 염증이 생길 수도 있음)

5. 난관

- 누설성 난관염 → 임상에서는 거의 못 봄 (대부분 성병원성 박테리아가 침범)

[참고]

- 앞으로 임상에서 가장 많이 만나게 될 질환은 칸디다 질염, 진단에 도움이 될 질환은 세균성 질증이므로 잘 알아두기
- 대부분 칸디다질염의 재발을 반복한 환자들을 보게 될 것
- 질염 치료시 결국 문제는 '재발'인데 겉으로 보여지는 증상이 없어지면 환자들이 더 이상 약을 먹지 않으므로 그 이후까지 환자를 끌고 가 치료하는 것이 중요함.

3절 대하의 한방 외래진료 p.306

대하 파트 자세히 보기

1. 개술

- 우선적으로 항생제를 중심으로 한양방 협진 치료 고려
↳ 꼭 그럴 필요는 없음
- 만성적으로 변한 경우는 한방치료 또는 한방과 양방 치료 병행

2. 병인병기

- 기본 병기는: '습' (습열은 소양감+염증 증상, 한습은 분비물 많지만 소양감 X)
- 신과 비 → 신기부족 비위기능장애로 임맥이 약해지고 대맥기능 견고하지 못하여 하여 몸의 수습이 생식기로 흘러 체외로 대하가 흐르는 것
↳ 신기가 약한 것은 에스트로겐 작용이 문제가 있는 것, 비기가 약한 것은 습사와 관련

3. 진단과 감별진단

- 문진: 기간, 분비물의 상태, 악취 유무, 자극 유무, 지속성 유무
↳ 칸디다와의 구분을 위해 중요 (칸디다는 악취가 나는 경우 별로 없음)
+ 성병 노출 여부 / *탐폰 사용 유무 / 최근 항생제 사용 / 감염의 기왕력, 알레르기
*탐폰은 여성의 몸에 생리대보다 훨씬 더 안 좋음.
- 감별진단: 백탁 / 백붕 / 경간기 출혈 / 루하 (중요 X)
↳ [교수님설] 교수님이 본 환자는 가려움, 동통 없이 하얀 분비물만 늘어난 상태로 치료를 했지만 실패함 → 비기가 돌아오고 대맥이 다시 묽이는 기간이 필요한데 환자 입장에서는 우선 C/C의 변화를 단기간에 보여줘야 환자가 치료에 임할 수 있음. 당장 표증에 집중을 했어야 하는데 너무 마일드한 약을 사용했다는 아쉬움이 있음.

4. 변증치료 ★★★

변증	관련 증상	소증	설	맥	치법	처방
비허 ¹ '17 (세균성질증)	양다 색백 혹 미황 취기무	면색위황 소력 음식부진 수축냉 변당	담 태백	세약	건비익기 승양제습	완대탕 삼령백 출산
신양허 ¹ '11,13,17 (세균성질증)	양다 질희 색백 취기무	면암 요산 하복 냉 외한 소변빈삭 변당	담 태백	침지	온보신양 고삽지대	내보환 보궁환
신음허 ¹ '11,13,17 (위축성질염)	양소 색담홍 질점조 취기무 臍堅삭 작열감	안면조열 두훈 목현 요통 이명 眠淺 다몽 구건 변경 소변황	홍 태소	세삭	익신자음 청열지대	지백지황탕 가감 (고삼사상자탕)
습열 ² '07,10,11, 13,15,17 (ex. 칸디다)	양다 색황 질점조 포말상 혹 색백 두 부찌꺼기 성상 혹 혈락취기 외음부/질의 소양 감/동통	홍협고만 유방 창통 구고인건 소복통 소변황 변설	홍 태황 니	현활	청열이습 지대	지대방 ³ 금출저피환 ³ 금백저피환 ⁴ 용담사간탕 ⁵ 비해삼습탕
습독 (ex. 골반염 증성질환)	양다 색황 질점조 혹 농성 혈흔 <u>미감수</u> 성상, 취기심 소복타태통 심한 소양감 작열감	홍민 번열 구건 소변황 양소 대변경결	홍 태황 건	활삭	청열해독 제습	오미소독음 가미

- 비허, 신양허: 증상이 세균성 질증과 비슷 (초기치료에 해당 처방을 적용시키기는 어려움)
- 습열: 염증화 되어 홍종열통이 나타나는 것이 기본! 증상의 경중에 따라 칸디다, 트리코모나스 질염이 해당될 수 있음.
- 의학입문 처방으로, 습이 더 많으면 금출저피환, 열이 더 많으면 금백저피환을 쓰라고 하였음. (구분 안하고 써도 될 것 같다고 하심) 저근백피가 잘 없어 많이 쓰지 않는 약재임.
- 금출/백저피환보다 용담사간탕 사용하는 것을 추천함. 용담사간탕은 '열'에 더욱 초점을 맞춘 처방. 용담사간탕 사용할 때 꼭 먼저 맛을 보고 환자한테 주어야 함. (교수님 환자는 마시자마자 토하고 하고 울었던 적이 있다고 함)
- 비해삼습탕은 '습'에 초점을 맞춘 처방 → 용담사간탕과 비해삼습탕 비교 알아두기
*위축성질염 추천처방: 고삼사상자탕
- 차가운 약으로 외치로 사용, 약재들을 가감하여 사용하는데 교수님은 석고 사용했었음.
- (위축성 질염은 환자의 상태에 따라 처방 주의해서 사용할 것)

2장 기타 생식기 증후와 질환 p.312

중요도 낮은 잡병들! 한의원 올만한 질환은 그나마 음양 정도이고, 간단하게만 알아보겠음.

1절 음통 (외음부 동통) p.312

1. 개술

- 여성 음증 혹은 음호에 통증이 있거나 때로 음부에 잡아당기는 듯한 통증이 있고 심한 경우 소복부나 위로 유방까지 통증이 미치는 경우 (음창에 의한 것을 제외한 질환)
- 음통 환자들은 통증과 함께 질의 건조나 외음부의 홍종(발적) 동통 호소
- 陰中痛名小戶嫁痛, 痛劇手足不能舒 <의증금감, 부과소법>
 - ↳ 음통을 가리키는 말이라고 보기는 어려우며 질 입구가 너무 좁아져서 나타나는 통증을 의미함.

※ 외음부 전정염 증후군 (음통에 해당하는 비슷한 서양의학적 병명)

- 원인은 잘 밝혀지지 않았음.
- 전정부나 질입구의 심한 통증, 질전정부에 국한된 압통, 전정부 발적 및 이에 따른 이학적 소견

2. 병인병기

- 외음과 음호는 경락과 종근이 모이는 곳인데, 충임맥과 족삼음경이 모두 여기를 돌아 지나간다.
- 간은 근을 주관하고 **족궐음간경**이 음부를 둘러싸고 있으므로 간은 특히 음통의 발생과 연관이 많다 → 간신음허, 간경울화
- 성과 관련된 사회력의 청취도 중요하며, 과거 혹은 현재의 성적 외상 병력도 체크 필요 → 원래 외인을 중요시했으나 명청대 이후에 내인(간경과의 관련성)에 주목
- 진단시 음창과 감별해야 함.

3. 변증치료 ★★★

변증	관련 증상	소증	설	맥	치법	처방
간신음허	질건삽 작열감, 소량 황색 분비물, 외음부 위축, 질내부 홍종 (위축성 질염)	현훈 요냉 면천 수족번열 시열 상충 냉한 구건 변비 소변황소	설홍 열태황	맥세삭	자신양간 청열강화	지백지황탕 좌귀음
간경울화 '17	음부순통, 빠근하게 아픔 혹은 작열감	소복 유방창통 홍민 선택식 면천 정지역 울 음식무미	설홍 태황백후	맥세현	소간해울	단치소요산 천련탕 자수청간음
습열하주	외음부 종통, 황백색 대하, 외음 및 질의 충혈/궤양	소변황소	설홍 태황니	맥세유삭	청리습열 조리간비	용담사간탕 이황탕
기허하함	음부타태통 혹은 백색 대하	피곤 무력 라인 면색무화 두훈 음식 소량	설담홍 태박백	맥세연	보중승양	보중익기탕 거원전
풍냉옹조 '17	산후기거태조, 산문 감풍작통, 의피난근 신체	산후 전신골절동통 신냉 외한 전신소력	태백후	맥세	거풍산한 화락지통	거풍정통탕 창포산 +형개, 방풍

※간경울화, 풍냉옹조가 그나마 중요하다고 말씀하심

※천련탕: 천련자는 독성이 있어 사용 주의

※기허하함: 추타통(아래가 빠질 것 같은 통증)은 PID에서도 나타나기 때문에 추타통이라고 기허하함이라고 볼 수 없다는 점을 주의할 것

※음통을 크게 나누면, 상복 / 하복으로 나눌 수 있음.

- 상복쪽은 가미건중탕 (허증에 가까움, 허증 골반통)

- 하복쪽은 가감반중산 (실증에 가까움, 소복산통)

2절 음창 陰瘡 p.321

1. 개술

- 여성의 음호에 창이 생겨 발적, 종, 열, 통 등이 나타나며, 오래되어 덩어리를 형성하거나 혹은 화농하고 혈어서 농액이 흐르며 심하면 벌레먹은 것처럼 궤양되는 것
- 陰蝕, 陰癰(누에고치처럼 변하는 것, 성병에서 자주 보임) 라고도 함.
- 광약: 음창 陰癰 음증 음탈 陰癰 등을 포괄 “알 필요 없다”
- 협의: 성기의 궤란, 통증, 가려움 등이 있는 상태

2. 병인 병기

	증상	치법	처방
열독	- 腺은 부어오르고 통증 유발 - 가만히 눌러서 그 腺管으로부터 농성 삼출물을 짜낼 수 있고, 저절로 흘러나오기도 함. - 설태항니 맥침이활삭	청열해독 활혈화어	오미소독음 + 유향, 몰약, 적작 약, 목단피 선방활명음
한응	- 음창의 피색이 변하지 않음 - 종통이 심하지 않음 - 경과가 오래되어도 없어지지 않음 - 창구가 수렴되지 않음 - 신피권태, 식육부진, 심계번조 등 동반 가능 - 설담눈 태박황 맥세연무력	익기양혈 탁독외출	탁리소독음, 양화탕

*열독 원인: 기후가 덥거나(외인), 心肝之火(내인), 기름지고 열량이 많은 음식(불내외인)

*한응 원인: 풍한(외인) 비히허약(내인) 부적절한 성생활(불내외인)

- 열자청지, 한자온지, 건자소지, 허자보지, 下陷托之止
- 열독: 청열해독 소종산결
- 한응: 청열해독 부정탁독

4. 질과 외음에 발생하는 관련 질환

바르톨린선염	외상 염증 등 바르톨린선의 분비 배액 장애, 동통, 부종, 농양 발생
립슈쓰 궤양	- 외음부의 비특이적 궤양 (질하부의 발생빈도가 더 높음.) - 보통 자극이 원인: 국부외상, 자위 시 손상, 낭창 등 전신성질환
베체트병	- 난치성이고 꾸준한 관리 요하는 자가면역 질환 - 20-30 대에 호발하는 전신성 혈관염 - 특징: 점막조직에 특화되어 있어, 눈/구강/음부를 침범함. 더욱 진행되면 피부 및 CNS 까지 침범할 수 있음. - 증상: 재발성 전방 축농성 홍채염, 구강 아프타 및 음부 궤양의 세 징후를 반복적으로 나타냄. - ※호혹과 관련됨. - 진단 by Pathergy test: CELL line 으로 하는 간단한 검사. cell line 을 자입한 곳에 무균성 농포가 생기면 베체트병

★ 狐惑을 구분하고 간단히 설명하시오. '19

※호혹 狐惑

- 감병 중 하나, 인후부/음부/항문이 허는 병증(궤양)
- <금궤요략>에서 疳病에 속하는 질병으로, ‘호’는 下疳을 ‘혹’은 牙疳(上疳)을 의미
- 하감(아래가 혈면): 전음이 혈면 고삼탕으로 씻고, 후음이 혈면 웅황을 혼연한 연기를 켜다.
- 아감(인후가 혈면): 감초사심탕

3절 음양 陰痒 p.326

1. 개술

- 여성의 외음부 및 질에 심한 가려움이 있으나 경우에 따라 대하의 양이 증가
- 음문소양 혹은 陰蠱(음익, 벌레 먹는 병)라고도 함.

2. 치료

- 외음 소양증은 기본적으로 증상을 유발한 원인 질환을 치료
- 환자가 **긁지 않도록 하는 것**이 가장 중요!

3. 변증치료

변증	주증	소증	설	맥	치법	처방
습열하주	대하 양다 포말상 외음 및 질 홍종 충혈	홍민 면천 구고 음식무미	설태항니	맥현삭	청열삼습 살충지양	용담사간탕
간신음허	음부건삽 작열감 대하양다 색황 심하면 혈성	오심 번열 두훈목 현 시시홍열 한출 구건불욕연 이명 요냉	설홍태소	맥세삭 무력	자음강화 조보간신	지백지황탕 기국지황탕
심간울화	소양감 야간에 심해짐 검사상 특이소견X	홍민 번조 이노 우울감 면천	설홍 태항니	맥현세삭	청간해울	단치소요산 가감소요산 +지모 지골 피 차전자 가미귀비탕 +시호 치자 목단피 작약

- 간신음허: 위축성질염 관련
- 심간울화: 정신적 요인 관련 → 교수님 본 적 없음.

4. 기타 치료법

① 외치법 <양의대전>

- 사상자세방(蛇床子洗方), 탐양탕(塌痒湯), 진주산(珍珠散) 등을 이용할 수 있음.
(심간울화형에는 외치법이 보다 중요함.)
- **고삼사상자탕** 가감하여 쓰는 것을 추천. 기본적으로 말리는 작용을 보유하며, 찬 약에 속함. 습이 많으면 백반을 섞고, 열상이 많으면 치자/황금/황백 등을 가미

② 에스트로겐과 안드로겐: 일반적으로 국소용 에스트로겐 크림은 질 상피를 비후시키고 외피를 연화시킬 뿐 소양증 치료에는 도움이 안 됨

4절 음냉 陰冷 p.332

1. 개술

- 외음과 음중에 한냉을 느끼고 심하면 냉기가 아랫배와 서혜부까지 미치는 것
- 성욕저하나 불감증이 동반되기도 함 (갱년기)

2. 병인 병기

신양허쇠 간경울결 한습담조 + 신기쇠 / 성에 대한 반감 우울증 (심리적 요인)

3. 변증치료 (천태오약산 별로라는 것 외에 언급 안하심)

변증	주증	소증	설	맥	치법	처방
신양 허쇠	외음 음호 한 냉 심하면 소복냉통	성욕저하 신냉 소변청장 요척 腰尻냉통 식욕부진 변당 심신무력	설담반 태박백	맥침완	온보신양	신기환 우귀환 이음전
간경 울결	외음 음호 한냉	성욕없음 심하면 성을 혐오 경전 유방홍협창통 홍민 선택식 불안	설태박	맥현	소간해울	청간해울탕 +시호
한습 담조	외음 음호 한냉	요냉통 전신골절냉통 성 욕저하 체비 전신소력 기면 식욕저하 변설	설담반 태박백 니	맥유완	온경산한 화습척담	천태오약산 +부자 세신 애엽 창부도담환 + 음냉방

- 천태오약산: 교수님께서 써보셨는데 그닥 효과를 얻지 못함.

4장 골반염증성질환 (PID) p.357

1절 골반염증성질환 p.357

★ 골반염증성 질환은 한방적으로 (邪客子門), (熱入血室)로 표현된다. 원인으로서는 (난관염)과 (난소주위염)이 대부분을 차지한다

- 박테리아 혹은 드물게 바이러스 감염에 의해 자궁목상부의 생식기에 염증이 야기된 질환
- 자궁내막염, 난관염, 난소주위염, 난소종양 등과 그로 인한 골반 내 복막염을 총칭한다
- 邪客子門 熱入血室

★ [강조] 골반염증성 질환과 관련된 후유증 '12,13,18,19

① 난관인자의 불임증	난관에 염증이 생기면 유착이 생기기 쉬워 난관이 폐색되고, 정자가 통과하지 못해 불임이 생긴다
② 자궁외임신	난관이 완전히 폐색되지 않고 일부만 폐색되면 정자는 통과하지만, 수정란은 통과하지 못하여 난관에 착상하게 됨.
③ 만성 하복부 동통	
④ 재발성 골반 감염	재발성 급성 골반염증을 일으킴 여성에게 생식기 계통 염증은 잠복성 염증과 같음. 한번 이환된 후에는 면역 떨어질 때 계속 재발
※검증 하부 비뇨생식기 계통의 염증	질과 요도부가 가까워 골반염이 요도염/방광염 등의 하부 비뇨생식기 계통의 염증을 일으킬 수도 있음.

*기존 악마에는 ⑤까지 있으나, 개정된 교과서에는 ④까지만 기재되어있음.
→ 하부비뇨생식기계통의 염증은 후유증이라기보다는 검증이라고 말씀하심.

1. 감염에 대한 방어인자 ★

★ 질 세균 감염을 막는 방어 인자에 대해 쓰고 설명하시오 '14,09,07(해부학적 인자)

해부학적 인자 '09,07	① 질 분비물	- 완전성을 유지하면서 - 탐식세포와 함께 병원성 세균의 질 내 침입을 차단
	② 경관 점액	- 겔 형태, 세포가 다량 함유되어 세균의 상행감염을 기계적으로 차단 - 경관점액의 lactoferrin은 항균 작용으로 세균의 침습을 막음
	③ 자궁내막의 분비물	- 자궁근층과 섬모들의 활동을 증진시켜주고, 상부 생식기에 존재하는 세균과 탈락된 세포들이 밖으로 배출되는 것을 가능하게 함
	④ 난관 속의 액체	- 분비물 내부에 존재하는 lactoferrin과 lysosome의 효소화 작용으로 살균 가능
면역학적 인자	- 점막에 여러 림프조직과 림프구, IgA 등 면역 글로불린이 존재	
정상 균주에 의한 방어인자	- 주로 호기성균, 특히 과산화수소를 생산하는 유산균(lactobacilli) - 정상 질의 산도는 pH4.5 이하로 유산(lactic acid)의 생산으로 유지 됨	

2. 위험인자

★골반염증성질환은 성적접촉에 의한 (임균),(클라미디아) 등과 같은 다발성 미생물에 의한 감염이다. '05

- 일차적으로 PID 의 위험요인은 하부외생식기에 감염된 임균/클라미디아에 의한 감염
- 성관계가 왕성하고 대상자가 다수인 젊은 여성도 위험인자로 간주됨
- 인위적 요인: 자궁내피임장치(2-9 배), D&C(소파술), 자궁난관조영술, douche(외음부/질 세척)

* 원인균

- Neisseria gonorrhea
- Chlamydia trachomatis (PID 에서는 성병 검사하는 것이 일반적)
- Haemophilus influenza (세균성 질증)
- polymicrobial infections

- 콘돔과 diaphragm 사용으로 위험성 감소시킬 수 있음.

3. 병태생리

- 대부분의 골반염증성질환은 상행감염에 의한다
- 이행: 자궁경부염 - 자궁내막염 - 난관염 - 난소 및 난소주위염 - 복막염 - 난소염/난소농양
↳ 난관염, 난소주위염이 흔한 형태

3. 진단

1) 진단

★ 골반염증성 질환의 진단상 3 가지 증상 혹은 징후를 기하시오 '08

(1) 증상과 징후

- ① 골반통 또는 하복부 동통
- ② 자궁목 움직임에 따른 통각 및 부속기 통증
- ③ 발열 (급성염증에서만 나타남)

→ 활용도 낮음 ②가 중요한데 환자의 통증 때문에 자궁목 움직임에 따라 평가하기 어려움.
대부분 만성이라 발열도 안타날 수 있음. 급성인 경우 치료하지 말고 양방에 보내는 것이 좋음

* 진단적 징후

- signs of lower genital tract infection - leukorrhea / mucopurulent
- lower abdominal tenderness 하복부 압통 (거안: 손도 못대게 함)
- cervical motion tenderness 자궁경부움직임에 따른 압통 (실제 의미는 없음)
- bilateral adnexal tenderness 양쪽부속기 압통
- palpable adnexal swelling
- temperature > 38 도 (발열은 급성기에 나타나는 증상에 해당하여 안타날 수도 있음)

(2) 검사실 소견

- leukorrhea
- erythrocyte sedimentation rate > 20mm/hour
- elevated C-reactive protein > 2mg/dl
- endometrial biopsy : endometritis

+) 추가로 해야 할 검사 소견

① Preg-test: 자궁외임신 때문에 임신테스트

② 일반 혈액 검사 : CBC(백혈구검사) ESR(적혈구침강속도) CRP(염증성검사) UA(소변 검사)

③ 성병검사 : 성전파성 감염이 의심 시

✓ PID 는 증상이 다양하여 진단이 매우 어렵고, 확진 후에 적절한 치료를 한다는 것 또한 신중하게 생각해야 함. 진단명도 함부로 사용하지 않음.

2) 감별진단

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① 비성전파성 골반 염증성 질환 | ⑤ 급성 충수염(초기엔 심하게 체한 느낌이 드는 것이 감별 포인트) |
| ② 자궁외임신(hCG 확인) | ⑥ 급성 신우신염 |
| ③ 자궁내 피임장치에 합병된 골반염증성 질환(IUD 문진 필요) | ⑦ 부속기 염전 |
| ④ 파열된 난관 난소 농양
(쇼크를 일으킬 정도의 맹렬한 통증) | |

6. 비정형성 (잠복성) 난관염 = 클라미디아 감염

[밀줄친 부분만 언급하고 넘어가심]

- 골반염인데 염증이나 통증 발열 대하 등의 증상이 나타나지 않고 난관협착이나 폐쇄등의 증상이 있는 경우다
- 임상에서 난관인자의 불임증으로 주소로 오는 환자의 50% 정도는 골반염증성 질환의 기왕력이 없음
- 자궁외임신이나 난관원위부의 협착 있는 무증상 환자에서 클라미디아 항체가 종종 발견
- 클라미디아 트리코모나스에 의해서 감염된 경우
- 전형적 증상이 없어도 난관점막의 형태학적 변성과 난관섬모상피의 생리학적 변성을 유발해서 나타나는 현상이다

7. 난관 난소의 농양

[수업 X]

- 급성골반염증성 질환의 말기적 상황임.
- 입원치료가 원칙이며 항생제 치료 실패 시 수술

8. Fitz hugh curtis syn.

★Fitz hugh curtis syndrome(FHC)의 병리와 증상을 쓰시오 '12

정의	이전에 난관에 염증성 질환을 앓았던 환자에 있어 간 표면과 복막 사이에 '바이올린 현' 모양의 유착이 특징적으로 나타나는 것
병리	급성 난관염으로 인해 복막염 발생하여 간 주위 조직에 유착 발생
증상	우상복부 통증(RUQ pain) 호소 (때문에 담낭염으로 오해하기도 함)
진단	CT로 진단 (간기능과 상관없으므로 LFT(간기능 검사)와 복부 초음파에서 정상소견)

- 10% 이내에서 발현되는 흔하지는 않은 증후군

9. 예방과 치료 평가

1) 환자의 치료평가

- 열이나 압통 사라짐
- 혈액학적으로 백혈구 증가증이 없어짐
- 골반조직의 동통이 현저히 개선

2) 예후

(딱 한번 감염되었어도 이후 계속 잠복하는 경향)

- 재발 25%
- 만성하복통 18%
- 불임 12.2%
- 사망 8.6%

2절 만성 골반염증성 질환 p.367

- 급성 골반염증성 질환에서 진행
- 골반유착, 난관의 완전 또는 부분폐쇄

1. 병리

- ① 난관 수종 - 단순형 / 여포성 난관 수종
- ② 결절성 협부 난관염
- ③ 만성 난소주위염 → 모든 염증성 질환의 제1원인은 피로

2. 한방치료

증상: 하복통, 만성피로, 두통, 현훈

✓변증별 교수님픽 기본방

- ① 간신부족 → 난간전
- ② 비신허약 → 반총산
- ③ 심간기울 → 소요산 온담탕 귀비탕

3. 진단

- 골반염 진단은 매우 어려움
- 골반염 증상들이 다른 질환에서도 나타날 수 있어 감별이 쉽지 않음
- 과거 명절 신드롬으로 불렸으며 추타통이 특징적으로 나타남

약물 보류 관장요법

★약물보류관장요법의 장단점을 쓰시오 '12

목적	직장내로 주입된 약물이 직장점막을 흡수 통과하여 직접 병소에 도달하게끔 함으로써 ① 골반강의 혈액순환을 개선하고 ② 비후된 결합조직을 연화하고 ③ 조직의 재생을 촉진하기 위해 사용
장점	- 경구투여에 비해 흡수가 빠르고 간 대사를 경유하지 않으며, 소화효소에 의한 파괴가 없음. - 혼수나 심한 구토 등으로 내복할 수 없는 경우에 적합. 골반은 혈관과 정맥이 얇고 판막이 없으며 직장과 자궁동맥이 서로 연관되어 있음
단점	- 항문 감염성 질환이 있는 경우 적합하지 않고, 경구 투여에 비해 불편함
방법	- 환자가 시술 전 대소변을 비우고 굴슬측와위 자세를 취한다 - 약액을 탕전해 100ml-200ml로 농축 - 35-40도 정도의 온도 유지 - 항문 내 12-15cm정도 깊이로 관장기 삽입 후 완만히 주입 - 30-40분 이상 보류 - 매일 시행하는 것이 원칙 - 청열해독 소종배농 거어지통 효능 약물들 사용 예) 패장초, 홍등, 적작약, 자화지정, 포공영, 단삼, 금은화, 향부자, 백화사설초, 시호, 현호색, 고삼, 연교, 목단피, 삼릉, 유향, 도인 → 제일 많이 쓰인 것이 1위 패장초, 2위 홍등(구할 수 없는 약재), 3위 적작약